

УДК:616.71/72-006.6-08

Г.А. Серикбаев, Ж.О. Мауленов, А.К. Курманалиев, Д.А. Тулеуова,
Г.С. Ахметова, Орманов К.М.
Казахский НИИ онкологии и радиологии

Современное состояние хирургического лечения опухолей костей таза в Казахстане

Аннотация. Лечение злокачественных опухолей костей таза до сих пор остается сложной проблемой клинической онкологии. Операции при опухолях костей таза являются менее разработанными и недостаточно освещенными в литературе по сравнению с заболеваниями других отделов опорно-двигательного аппарата.

Ключевые слова: Опухоли костей таза, хирургическое лечение, объем резекции, морфологическая структура опухоли, органо-сохранные операции, эндопротезирование.

В 1978 г. W.F. Ennekingi WK. Dunham опубликовали работу, в которой попытались систематизировать резекции таза. Авторы предложили разделить таз на 4 зоны: I — крыло подвздошной кости, II — периацетабулярная, III — среднее полукольцо таза, IV — крестец

По нашим данным при локализации опухоли в I зоне хирургическому лечению подверглись 15 (19,2%) пациентов, во II-ой – 36 (46,1%), в III-ей – 7 (8,9%) и в IV-ой – 20 (25,6%) пациентов.

Первичные опухоли костей встречаются сравнительно редко. Их частота не превышает 1% от всех злокачественных новообразований человека. По литературным данным, заболеваемость составляет у мужчин 1, а у женщин 0,6—0,7 случая на 100 000 населения. Опухоли костей в большинстве случаев возникают у лиц молодого и среднего воз-раста. Чаще поражаются длинные трубчатые кости и кости таза.

Статистические данные за 10 лет представлены на рисунке 1.

Лечение злокачественных опухолей костей таза до сих пор остается сложной проблемой клинической онкологии. Операции при опухолях костей таза являются менее разработанными и недостаточно освещенными в литературе по сравнению с заболеваниями других отделов опорно-двигательного аппарата. По данным Н.Н. Трапезникова с соавт., удельный вес первичных злокачественных опухолей костей таза составляет 15,7% от всех злокачественных опухолей костей. По литературным данным известно, что в костях таза доброкачественные опухоли встречались в 2—3 раза реже, чем злокачественные, а в костях конечностей доброкачественные процессы встречаются чаще. Злокачественные опухоли костей таза имеют худший прогноз, чем при локализации в длинных трубчатых костях. Этот факт связан с несколькими причинами. Во-первых, большинство пациентов обращаются в специализированные учреждения при наличии опухоли уже достаточно больших размеров, особенно при росте ее в полость таза. Во-вторых, кости таза являются сложной зоной для рентгенологического обнаружения опухоли. В-третьих, сложное пространственное строение таза, близость жизненно важных структур (магистральных сосудов, нервов, органов малого таза) часто делают невозможным выполнение радикального оперативного вмешательства. Кроме того, пациентам этого профиля нередко в ортопедических клиниках выполняют неадекватные операции, что также ухудшает прогноз.

К сожалению, большинство пациентов в нашей стране не получают квалифицированной диагностики и ле-

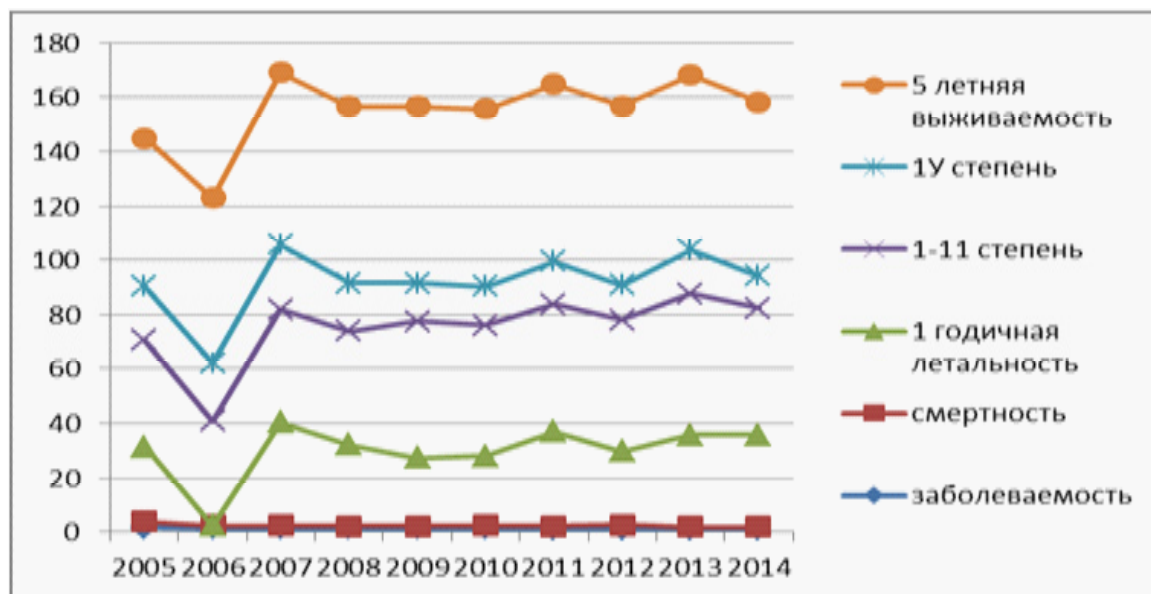


Рисунок 1 - Статистические данные за 10 лет

чения на местах и прибывают с запущенными формами опухолей. Позднее обращение больных в специализированные учреждения значительно усложняет лечение, а зачастую служит отказом от лечения. По данным М.Д. Алиева с соавт. (2006), около 80% пациентов до установления правильного диагноза проходили лечение по поводу других неонкологических заболеваний.

Хирургическое лечение опухолей костей таза отличается высоким риском развития интра- и послеоперационных осложнений, наиболее грозными из которых являются кровотечение и инфицирование раны с последующим развитием сепсиса. Резекции костей таза требуют знания онкологической ортопедии, сосудистой, абдоминальной, пластической хирургии, нейрохирургии. Тем не менее, с развитием анестезиологии, реанимации и трансфузиологии увеличивается количество и объем оперативных вмешательств.

Все эти факторы обуславливают:

- необходимость совершенствования оперативных методик и доступов;
- поиск новых возможностей реконструкции костных и мягкотканых дефектов;
- развитие методик профилактики и лечения осложнений;
- выбор адекватного объема оперативного вмешательства в зависимости от гистологической формы опухоли с целью снижения числа рецидивов.

В данной статье представлены непосредственные результаты хирургического лечения опухолей костей таза у 78 пациентов, в период с 2005 по 2014 год включительно.

В 1978 г. W.F. Enneking и W.K. Dunham опубликовали работу, в которой попытались систематизировать резекции таза. Авторы предложили разделить таз на 4 зоны: I — крыло подвздошной кости, II — периацетабулярная, III — среднее полукольцо таза, IV — крестец (рисунок 2).

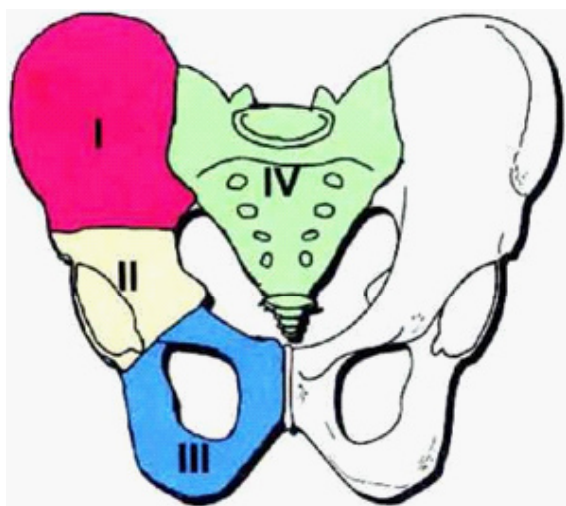


Рисунок 2 – Зоны резекции таза

По нашим данным при локализации опухоли в I зоне хирургическому лечению подверглись 15 (19,2%) пациентов, во II-ой – 36 (46,1%), в III-ей – 7 (8,9%) и в IV-ой – 20 (25,6%) пациентов.

Таблица 1 - Морфологическая структура

Гистологическая форма	Количество	%
Хондросаркома	40	51,2
Злокачественная фиброзная гистиоцитома	6	7,6
Остеосаркома	3	3,8
Саркома Юинга	1	1,2
Фибросаркома	1	1,2
МТС в кости	4	5,1
Саркомы мягких тканей	3	3,8
Гигантоклеточная опухоль	13	16,6
Прочие (эхинококк, тератома, киста, ганглионевринома, хордома)	7	8,9
Всего	78	100

Наибольшее количество больных было с хондросаркомой кости (51,2%) и гигантоклеточной опухолью (16,6%)

Таблица 2 - Различные виды резекции костей таза

Зоны резекции	Количество	Процент
Резекция I-II-III зоны (органосохранная операция + эндопротезирование)	8	10,2
Резекция I зоны (с пластикой)	15	19,2
Резекция II-III зоны (эндопротезирование)	5	6,4
Резекция III зоны	7	8,9
Резекция IV зоны (резекция крестца на уровне S2-S3)	20	25,6
Резекция I-II-III зоны (межподвздошно-брюшная ампутация)	23	29,4
Всего	78	100

Таким образом, хирургическое вмешательство с применением реконструкции выполнено 23 пациентам. Из них реконструкция с применением спиц Киршнера и костного цемента проведена 15 (65,2%) пациентам и эндопротезирование 8 (34,7%).

В раннем послеоперационном периоде осложнения возникли в 8 (10,2%) случаях. В том числе инфекционные осложнения у 2 (2,5%) и неинфекционные у 6 (7,6%). Умерло в раннем послеоперационном периоде 2 (2,5%) пациента. В первом случае причиной явилось острая полиорганная недостаточность, во втором – геморрагиче-

ский шок.

Появление КТ, МРТ и трехмерного моделирования позволило с большой точностью определить истинные границы распространения опухоли и планировать линию резекции и при необходимости возможные варианты реконструкции. Благодаря этому удалось повысить радикальность оперативных вмешательств и таким образом уменьшить количество рецидивов.

Заключение

• Подавляющее большинство больных, с данной патологией, обращается в специализированные учреждения тогда, когда опухоль уже достигает значительных размеров

• Тщательное предоперационное планирование, опирающееся на современное комплексное обследование, совершенствование хирургической техники с применением реконструктивно-пластических этапов операций, анестезиологического пособия, появление биоинертных имплантов для замещения обширных послеоперационных дефектов - позволило расширить показания для оперативных вмешательств у пациентов с опухолевым поражением костей таза.

• Улучшение качества жизни больного, результат максимально возможного восстановления опорной функции конечности в ранние сроки после оперативного вмешательства.

Список литературы

1. Арзыкулов Ж.А., Нургалиев К.Ш., Сейтказина Г.Д. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2005-2014 год. (стат. материалы).-Алматы, 2006-2014.
2. Алиев М.Д. Эндопротезирование как основа онкоортопедии //Поволжский онкологический вестник. -2012.- №2.- С - 14.
3. Алиев М.Д. Инфекционные осложнения эндопротезирования суставов у онкологических больных //Саркомы костей и мягких тканей. Научно-практ. ж. Восточно-Европейской группы по изучению сарком.-2011.№1.- С. - 3.
4. Алиев М.Д., Мусаев Э.Р. Хирургическое лечение первичных опухолей таза //Саркомы костей и мягких тканей. Научно-практ. ж. Восточно-Европейской группы по изучению сарком.- 2011.- №3.-С. - 4.
5. Aliev M.D., Nisichenco D.V., Saravanan S.A. et al. Instability of the endoprosthesis in bone tumors. A retrospective analysis //22th Annual Meeting of the European Musculoskeletal Oncology Society (EMSOS). 13-16 May, 2009.
6. Sokolovskiy V.A., Nisichenco D.V., Orekhov M.N. et al. Use of megaprotheses at total replacement of the femur at oncological patient //23th Annual Meeting of the European Musculoskeletal Oncology Society (EMSOS). 5-7 May, 2010.

Тұжырым

Ғ.А.Серікбаев, Ж.О.Мәуленов,
Ә.Қ.Құрманалиев, Д.А.Төлеуова,
Г.С.Ахметова, Қ.М.Орманов
Онкология және радиология Қазақ ҒЗИ

Summary

G.A.Serikbaev, Zh.O.Maulenov, K.Kurmanaliev,
D.A.Tuleuova, G.S.Ahmetova, K.M.Ormanov
Scientific Research Institute of Oncology
and Radiology

Қазақстандағы жамбас сүйектері ісіктерінің қазіргі заманғы хирургиялық емдеу әдістері

Contemporary condition of surgical treatment of pelvic bones` tumors in Kazakhstan

Жамбас сүйектерінің қатерлі ісіктерін емдеу қазіргі таңдағы клиникалық онкологияның күрделі мәселелерінің бірі болып табылады. Жамбас сүйектерінің ісіктері кезінде жасалынатын оталар тіреу-қимыл аппаратының басқа бөлімдерімен салыстырғанда, көп жетілдірілмеген және әдебиеттерде аз жарықтанған.

1978ж. W.F. Enneking және W.K. Dunham жамбас сүйектерінің резекцияларын жүйлендіруге бағытталған жұмысын жарыққа шығарды. Авторлар жамбасты 4 аймаққа бөлуді ұсынды: I – мықын сүйектің қанаты, II – периацетабулярлы, III – жамбастың ортаңғы жартысақинасы, IV – сегізкөз.

Біздің мәліметтерге сай I аймақтың ісіктері кезінде хирургиялық ем 15 (19,2%), II-ші – 36 (46,1%), III-ші – 7 (8,9%) және IV-ші – 20 (25,6%) науқасқа жүргізілді.

Түйінді сөздер: жамбас сүйегінің ісіктері, хирургиялық емдеу, резекция көлемі, ісіктің морфологиялық құрылысы, ағза-үнемдеші оталар, эндопротездеу.

The treatment of malignant tumors of pelvic bones still remains the difficult problem of clinical oncology. Operation of bones` tumors are less developed and insufficiently illuminated in literature compared with diseases of other departments of musculoskeletal system.

In 1978 W.F. Enneking and W.K. Dunham published the article where they tried to systematize pelvic resections. Authors proposed to divide pelvis on 4 zones: zone 1 – wing of iliac, zone 2 – periacetabular, zone 3 – middle semicircle of pelvic, zone 4 – sacrum.

According our data, if tumor located in zone 1, 15 (19%) of patients were undergone of surgical treatment, if in zone 2 – 36 (46,1), zone 3 – 7(8,9%), in zone 4 – 20 (25,6%) patients.

Keywords: tumors of pelvic bones, surgical treatment, volume resection, morphological structure of the tumor, organo-conserving surgery, arthroplasty (the surgical reconstruction or replacement of a joint).